הקבלה במרפאת טרום ניתוח

מה כותבים, איפה ואיך · תדרוך לסטאז׳רים ולמתמחים

על קוד של מתמחה
מציינים שהקבלה נכתבה על ידכם, כולל שם הסטאז׳ר/ית.

כל נושא ברובריקה שלו
בקמיליון: תרופות תחת תרופות, ניתוחים תחת ניתוחים.

לא משאירים לאשפוז
התורן בלילה עמוס. סוגרים הכול בטרום, כולל אק״ג.

בדיקה חסרה?
פקס למזכירת המחלקה: **08-9441790**

בסוף
מדפיסים וחותמים.

1 תלונה עיקרית

הופנה לניתוח _____ בשל _____ (האינדיקציה).

דוגמה: כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית בשל אירועים חוזרים של דלקת.

2 מחלה נוכחית

- פותחים ב: **בן/בת XX, סובל/ת מ...** ומחלות הרקע בכותרות. הפירוט בהמשך.
- הדמיה (CT, MRI): עיקרי הפענוח עם תאריך. רק מה שרלוונטי, בלי העתק־הדבק.
- יש גרורות מרוחקות? **מדברים עם המתמחה.**
- ממצאי הבירור לפי סדר כרונולוגי.
- מי הכירורג שהפנה ומה האינדיקציה.
- מבקשים סיכום מרופא המשפחה. חוסך זמן בתרופות ובמחלות הרקע.

3 מחלות רקע: מפורט ויסודי

- **מחלת לב איסכמית:** צנתורים, אילו עורקים, מתי ואילו תרופות. אישור קרדיולוג לסיכון הניתוחי ולהפסקת נוגדי קרישה.
- **פרפור פרוזדורים:** הטיפול הקבוע. **אירוע מוחי:** מתי ומה.
- **מחלת ריאות:** סיכום רופא ריאות והתייחסות לסיכון.
- בכל מחלה: יש ייעוץ? מה הוא אומר? חסר ייעוץ? מציינים.
- עוברים על כל התיק ומכניסים את כל הייעוצים.

4 בדיקות טרום ניתוח

טבלת הבדיקות הנחוצות בסביסטון ונהלי המחלקה. הכול מ-3 החודשים האחרונים.

אק״ג	מפרטים. אין, או באיכות לא טובה? עושים שוב.
צילום חזה	אין פענוח? מסתכלים וכותבים. **יש CT חזה? לא צריך צילום.** מציינים ברובריקה.
דם	המוגלובין, טסיות, לויקוציטים, קריאטינין, Na, K, INR. לפי הצורך: סמנים, אלבומין, מדדי דלקת. תאריך ברובריקה.
לא עדכני?	מכתב לרופא המשפחה עם הבדיקות. המטופל מגיע איתן ליום הניתוח.

5 ניתוחים בעבר

- מתי, איזה ניתוח ובאיזה חתך (למשל אפנדקטומי לפרוסקופי או מקברני).
- לא ברשימה? כותבים "לטיפול הרשמת" ואת שם הניתוח בהערות.

6 תרופות קבועות

- **דיוק! מוודאים מול המטופל ומול הרשומות.**
- מינון, תדירות ודרך מתן.
- נוגדי קרישה (אספירין, קומדין, פלביקס, קלקסן ודומיהם): מתי הופסקו ולמה ניתנים.
- מסבירים למטופל מה ממשיכים ומה מפסיקים.

והכי חשוב: מפעילים שיקול דעת ושואלים את המתמחה בכל שאלה.

7 מה מוסיפים לפי תחום

בקעים

- לפי מכתב ההפניה: איזה בקע, איזה תיקון ומה האינדיקציה.
- בדיקה: שני הצדדים והטבור. צלקות קודמות. בגברים גם אשכים.
- שואלים על מתן שתן ונוקטוריה.
- בקע בצלקת: אילו ניתוחים ומתי.

בריאטריה

- מדד מסת גוף (BMI), מחלות רקע ואינדיקציה. עוברים על כל המפגשים במרפאה הבריאטרית.
- שיקוף בליעה, גסטרוסקופיה ו-TSH.
- בדיקות דם: ויטמינים, פריטין ועוד.
- ניתוח קודם כמו טבעת: לציין את הסוג (LAGB, SRVG).

שד

- מרפאת השד או מכתב ההפניה: אפיון הגידול ואינדיקציה.
- **צד ימין או שמאל: חשוב!**
- כרונולוגיה: פתולוגיה, סמנים, סימון מתוכנן (איזוטופים או תיל).
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי, בדיקה גנטית ושיתוף פלסטיקאים.

קולון

- הערות המנתח.
- בירור סיסטמי: CT, צילום חזה, PET CT לפי הצורך.
- קולונוסקופיה ו-TRUS אם יש. פתולוגיה (כולל MMR), סמנים ו-MRI.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי והשיפור אחריו.

הפטוביליארי

- איזה ניתוח, התייצגות וסיבת הבירור.
- הבירור המקומי והסיסטמי לפי תאריכים. EUS ו-MRI: יחס לכלי דם.
- פתולוגיה ומרקרים. ניקוז דרכי מרה או ERCP.
- מעבדה: גם אנזימי כבד ובילירובין.

קיבה

- תוצאות גסטרוסקופיה ופתולוגיה.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי.
- תוצאות הבירור הסיסטמי (CT).

✓ לפני שמדפיסים

- ☐ תלונה עיקרית: ניתוח + אינדיקציה
- ☐ מי הכירורג שהפנה
- ☐ הבירור לפי תאריכים
- ☐ כל מחלות הרקע עם הייעוצים
- ☐ אק״ג, צילום חזה (או CT) ודם מ-3 חודשים
- ☐ כל ניתוח ברובריקה שלו, עם חתך
- ☐ תרופות: מינון, תדירות ודרך
- ☐ נוגדי קרישה: מתי הופסקו
- ☐ הוסבר למטופל מה ממשיכים
- ☐ נכתב ע״י: שם הסטאז׳ר/ית
- ☐ אין שום דבר שנשאר לאשפוז
- ☐ הודפס ונחתם

בעמודים הבאים

שלוש קבלות לדוגמה, כתובות לפי ההנחיות. לצד כל אחת: מה בדקנו ולמה.

1. **בקע מפשעתי** — תיקון לפרוסקופי עם רשת
2. **בריאטריה** — OAGB אחרי טבעת
3. **קולון** — כריתת סיגמואיד

קבלה לדוגמה · בקעים

1 תיקון בקע מפשעתי ימני בגישה לפרוסקופית (TAPP) עם רשת

גבר בן 58 · הפניה: מרפאת הבקעים

תלונה עיקרית	הופנה לתיקון בקע מפשעתי ימני בגישה לפרוסקופית עם רשת, בשל בקע סימפטומטי עם כאב במאמץ.
מחלה נוכחית	**בן 58, סובל מיתר לחץ דם, סוכרת סוג 2 והגדלה שפירה של הערמונית.** • מזה כשנה בליטה במפשעה ימין, מחמירה בעמידה ובמאמץ. ללא אירועי כליאה. • מכתב הפניה, כירורג מרפאת הבקעים (12/10/2026): בקע מפשעתי ימני, כנראה עקיף. מועמד לתיקון לפרוסקופי עם רשת. • אולטרסאונד מפשעות (28/9/2026): בקע מפשעתי ימני המכיל שומן. משמאל ללא בקע. • **בדיקה:** מפשעה ימין: בליטה רכה, נכנסת לבד, מתבלטת בשיעול. מפשעה שמאל וטבור: ללא בקע. ללא צלקות בבטן מלבד מקברני. אשכים תקינים בשני הצדדים. • **שתן:** נוקטוריה פעמיים בלילה וזרם חלש, מטופל בטמסולוסין. ללא אצירת שתן בעבר.
מחלות רקע	• יל״ד: מאוזן על אמלודיפין. • סוכרת סוג 2: HbA1c 6.9% (9/2026). ללא סיבוכים ידועים. • הגדלת ערמונית: במעקב אורולוג. • ללא מחלת לב ידועה. עולה שתי קומות בלי קוצר נשימה.
בדיקות	**אק״ג 5/10/2026**: קצב סינוס 74, ללא שינויים איסכמיים. **צילום חזה 5/10/2026**: שדות ריאה נקיים, צל לב תקין. **דם 5/10/2026**: Hb 14.6 · WBC 7.2 · PLT 245 · Cr 0.9 · Na 139 · K 4.3 · INR 1.0 · גלוקוז 132
ניתוחים בעבר	1985: כריתת תוספתן פתוחה (חתך מקברני).

תרופות קבועות

תרופה	מינון	תדירות	דרך	סביב הניתוח
Amlodipine	5 מ״ג	פעם ביום	פומי	ממשיך, גם בבוקר הניתוח
Metformin	850 מ״ג	פעמיים ביום	פומי	לא בבוקר הניתוח
Tamsulosin	0.4 מ״ג	פעם ביום	פומי	ממשיך
Aspirin	100 מ״ג	פעם ביום	פומי	מניעה ראשונית. הופסק 7 ימים לפני, לפי המנתח

רגישות לתרופות: לא ידועה.

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית _____ על קוד של ד״ר _____ ✓ הודפס ונחתם

מה בדקנו ולמה

- ✓ איזה בקע, איזה תיקון ומה האינדיקציה: לפי מכתב ההפניה.
- ✓ שני הצדדים, הטבור והאשכים. **הצד כתוב במפורש.**
- ✓ צלקת מקברני מופיעה גם בבדיקה וגם בניתוחים.
- ✓ שאלנו על מתן שתן: יש סיכון לאצירה אחרי הניתוח.
- ✓ אספירין: מתי הופסק ולמה ניתן.
- ✓ כל הבדיקות מ-3 החודשים האחרונים, עם תאריך.

מקרה בדוי להמחשה. ההנחיות לתרופות הן דוגמה בלבד, ובכל מטופל לפי המנתח וההרדמה.

2

קבלה לדוגמה · בריאטריה

מעקף קיבה בהשקה אחת (OAGB) בגישה לפרוסקופית

אישה בת 41 · הפניה: המרפאה הבריאטרית

תלונה עיקרית

הופנתה ל-OAGB בגישה לפרוסקופית, בשל השמנה חולנית עם תחלואה נלווית ועלייה חוזרת במשקל אחרי טבעת קיבה.

מחלה נוכחית

בת 41, סובלת מהשמנה חולנית, דום נשימה בשינה, יל״ד וכבד שומני.

- משקל 118 ק״ג, גובה 1.66 מ׳: **BMI 42.8**.
- 2015: טבעת קיבה מתכווננת (LAGB). ירידה של 20 ק״ג ועלייה חוזרת. 2019: הוצאת הטבעת בשל צרבת קשה.
- מרפאה בריאטרית: כירורג (3/8/2026), דיאטנית (שני מפגשים באוגוסט ובספטמבר), פסיכולוגית (20/8/2026, מתאימה), ועדה בריאטרית (15/9/2026, אושרה).
- שיקוף בליעה (7/2026): מעבר תקין, ללא בקע סרעפתי.
- גסטרוסקופיה (8/2026): גסטריטיס קלה. HP שלילי. ללא בקע סרעפתי.

מחלות רקע

- דום נשימה בשינה: בדיקת שינה 2024, AHI 32. ישנה עם CPAP. **תביא את המכשיר לאשפוז.**
- יל״ד: על רמיפריל.
- כבד שומני: ALT מעט מוגבר.
- טרום סוכרת: HbA1c 6.1%.

בדיקות

אק״ג 1/10/2026	קצב סינוס 82, תקין.
צילום חזה 1/10/2026	תקין.
דם 1/10/2026	Hb 12.4 · WBC 8.1 · PLT 310 · Cr 0.7 · Na 140 · K 4.1 · INR 1.0 · ALT 48 · אלבומין 4.2 · TSH 2.1
ויטמינים 9/2026	B12 310 · חומצה פולית 7.8 · פריטין 22 · ויטמין D 18 (נמוך, התחילה תוסף)

ניתוחים בעבר

2012: ניתוח קיסרי (חתך פפננשטיל). 2015: LAGB לפרוסקופי. 2019: הוצאת הטבעת, לפרוסקופית.

תרופות קבועות

תרופה	מינון	תדירות	דרך	סביב הניתוח
Ramipril	5 מ״ג	פעם ביום	פומי	לא בבוקר הניתוח
Omeprazole	20 מ״ג	פעם ביום	פומי	ממשיכה
Vitamin D3	2000 יח׳	פעם ביום	פומי	ממשיכה
CPAP	·	בלילה	·	להביא לאשפוז

רגישות לתרופות: פניצילין (פריחה).

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית _____ על קוד של ד״ר _____ ✓ הודפס ונחתם

מה בדקנו ולמה

- ✓ BMI ותחלואה נלווית: זו האינדיקציה.
- ✓ כל המפגשים במרפאה הבריאטרית, עם תאריכים.
- ✓ שיקוף בליעה, גסטרוסקופיה ו-TSH הועתקו.
- ✓ ויטמינים ופריטין. ערך חסר מטופל כבר עכשיו.
- ✓ **סוג הניתוח הקודם (LAGB)** ומה קרה איתו.
- ✓ CPAP: נכתב בקבלה כדי שלא ייתפס בלילה.

מקרה בדוי להמחשה. ההנחיות לתרופות הן דוגמה בלבד, ובכל מטופל לפי המנתח וההרדמה.

קבלה לדוגמה · קולון

3 כריתת סיגמואיד בגישה לפרוסקופית

גבר בן 67 · הפניה: המרפאה הקולורקטלית

תלונה עיקרית

הופנה לכריתת סיגמואיד בגישה לפרוסקופית בשל אדנוקרצינומה של הסיגמה.

מחלה נוכחית

בן 67, סובל ממחלת לב איסכמית, פרפור פרוזדורים התקפי וסוכרת סוג 2.

- 7/2026: דמם רקטלי ואנמיה קלה (Hb 11.2). קולונוסקופיה (14/8/2026): גידול חוסם חלקית בסיגמה, 25 ס״מ מפי הטבעת. סומן בטטו.
- פתולוגיה: אדנוקרצינומה בהתמיינות בינונית. **MMR תקין.** CEA 3.8.
- הדמיית CT חזה, בטן ואגן (25/8/2026): עיבוי דופן בסיגמה. ללא קשריות מוגדלות. **ללא גרורות** בכבד ובריאות.
- גידול בסיגמה ולא ברקטום: לא נדרשו MRI אגן ו-TRUS. ללא טיפול נאו־אדג׳ובנטי.
- הערות המנתח (2/9/2026): מועמד לכריתה לפרוסקופית. הוסבר על אפשרות לסטומה זמנית.

מחלות רקע

- מחלת לב איסכמית: 2021 צנתור עם תומכן ל-LAD. פלביקס הופסק ב-2022. אקו (6/2026): EF 55%. **קרדיולוג (10/9/2026):** סיכון ניתוחי בינוני, ממשיך אספירין, אפשר לנתח.
- פרפור פרוזדורים התקפי: על אליקוויס (ראו תרופות).
- סוכרת סוג 2: HbA1c 7.2%.

בדיקות

אק״ג 8/10/2026	קצב סינוס 68, ללא שינוי מאק״ג קודם.
צילום חזה	לא נדרש: יש CT חזה מ-25/8/2026. צוין ברובריקה.
דם 8/10/2026	Hb 11.8 · WBC 6.9 · PLT 280 · Cr 1.1 · Na 138 · K 4.6 · INR 1.1 · אלבומין 3.9 · CEA 3.8

ניתוחים בעבר

2010: כריתת כיס מרה לפרוסקופית.

תרופות קבועות

תרופה	מינון	תדירות	דרך	סביב הניתוח
Aspirin	100 מ״ג	פעם ביום	פומי	ממשיך (קרדיולוג)
Eliquis	5 מ״ג	פעמיים ביום	פומי	אחרונה 48 שעות לפני
Bisoprolol	2.5 מ״ג	פעם ביום	פומי	ממשיך, גם בבוקר
Atorvastatin	40 מ״ג	בערב	פומי	ממשיך
Metformin	1000 מ״ג	פעמיים ביום	פומי	לא בבוקר הניתוח
Jardiance	10 מ״ג	פעם ביום	פומי	הפסקה 3 ימים לפני

רגישות לתרופות: לא ידועה.

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית _____ על קוד של ד״ר _____ ✓ הודפס ונחתם

מה בדקנו ולמה

- ✓ הבירור לפי סדר כרונולוגי, כל ממצא עם תאריך.
- ✓ פתולוגיה כולל MMR, וסמנים (CEA).
- ✓ CT: האם יש גרורות. **אם היו, מדברים עם המתמחה.**
- ✓ יש CT חזה, ולכן אין צילום חזה. זה כתוב.
- ✓ ייעוץ קרדיולוג על הסיכון ועל אספירין.
- ✓ אליקוויס וג׳רדיאנס: מתי מפסיקים ולמה ניתנים.

מקרה בדוי להמחשה. ההנחיות לתרופות הן דוגמה בלבד, ובכל מטופל לפי המנתח וההרדמה.